جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : منال عثمان حسين عثمان
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** طره **العنوان :** ش
رقم البطاقة : 27307020103141 **رقم التليفون :** 01126520905 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 20-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 02-07-1973 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : ورم خبيث بالمبيض
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : ورم خبيث بالمبيض
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [6683] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: منال عثمان حسين عثمان
National ID: 27307020103141

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

A patient of ovarian cancer for Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	**الوقت :** -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



NationalID - From [[DOCTYPE:ID_FRONT]]


٢٧٣٠٧٠٢٠١٠٣١٤١ ٢٠٢٥/٠٤
ربة منزل
انثى مسلمة أرملة
١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٤/٠٩
Back

[[DOCTYPE:LAB_TEST]]
lab test

Fath Islamic
Clinical Laboratories
معامل الفتح الإسلامي للتحاليل الطبية

الأستاذ الدكتور
أحمد نبيه عجم
دكتوراه أمراض الدم والمناعة
معهد الأورام القومى - جامعة القاهرة

Lab.ID	21540	Req. Date	12-October-2026 13:7:33
Name	منال عثمان حسن	Age	53 Year Sex FEMALE
Referred By	أ.د / نقدى	Reporting Date	18-Oct-2026 18:50.56

Prothrombin Time

TEST	Result	UNIT	Reference Range
Control time	13	seconds	
Patient time	13.0	seconds	11.0 - 15.0
Concentration	100	%	70.0 - 110.0
INR	1		1.0 - 1.3

Lab Maneger

[[DOCTYPE:LAB_TEST]]
lab test

Fath Islamic
Clinical Laboratories
معامل الفتح الإسلامي للتحاليل الطبية

الأستاذ الدكتور
أحمد نبيه عجم
دكتوراه أمراض الدم والمناعة
معهد الأورام القومى - جامعة القاهرة

Lab.ID	21540	Req. Date	12-October-2026 13:7:33
Name	منال عثمان حسن	Age	53 Year Sex FEMALE
Referred By	أ.د / نقدى	Reporting Date	18-Oct-2026 18:50.54

Clinical Chemistery

Test	Result	Unit	Reference
Creatinine	0.9	mg/dl	0.50 - 1.20
AST (SGOT)	20	U/L	0.00 - 40.00
ALT (SGPT)	14	U/L	0.00 - 41.00

Hematology & Coagulation

Test	Result	Unit	Reference
Blood group (ABO)	(A)		
Rh group	Negative		

Tumor markers

Test	Result	Unit	Reference
CA-125	600	U/ml	*Up to 35.0*
CEA	1.1	ng/ml	*non smoker up to 2.5 ng / ml* *smoker up to 5.0 ng / ml*

Doctor's signature

[[DOCTYPE:LAB_TEST]]
lab test

Fath Islamic
Clinical Laboratories
معامل الفتح الإسلامى للتحاليل الطبية

الأستاذ الدكتور
أحمد نبيه عجم
دكتوراه أمراض الدم والمناعة
معهد الأورام القومى - جامعة القاهرة

Lab.ID	21540	Req. Date	12-October-2026 13:7:33
Name	منال عثمان حسن	Age	53 Year Sex FEMALE
Referred By	أ.د / نقدى	Reporting Date	18-Oct-2026 18:50.56

Complete Blood Count

TEST	Result	UNIT	Reference Range
HB	12.3	g/dL	11.50 - 16.50
RBC s	3.96	10^6/cmm	3.80 - 5.80
Heamatocrit(PCV)	37.7	vol%	37.00 - 47.00
MCV	95.2	fl	80.00 - 100.00
MCH	31.1	pg	27.00 - 33.00
MCHC	32.6	%	32.00 - 36.00
Platelets count	450	10^3/cmm	150.00 - 450.00
WBC s	9.8	10^3/cmm	4.00 - 11.00

Differential white cell count :

	Relative		Absolute	
	Result %	Normal	Result / cmm	Normal
Neutrophils	70	40.00 - 80.00	6860	2000 - 6000
Bands	2	1.00 - 6.00	196	
segmanted	68	40.00 - 65.00	6664	
Lymphocytes	26	20.00 - 45.00	2548	1500 - 4000
Monocytes	2	2.00 - 8.00	196	100 - 800
Eosinophils	2	0.00 - 6.00	196	40 - 400
Basophils	0	0.00 - 1.00	0	

Lab Maneger

[[DOCTYPE:MRI]]
M.R.I

Fatth Islamic Center

C.T. - M.R.I

U.S. - Duppler - E.C.G. Stress

E.E.G - E.M.G - Mamm - Eye Unit

الجمعية الشرعية

مركز الفتح الإسلامى

أشعة مقطعية بالكمبيوتر - الرنين المغناطيسى
موجات صوتية - دوبلر ملون - رسم قلب بالمجهود
رسم مخ - رسم عضلات - فحص ثدى - وحدة عيون

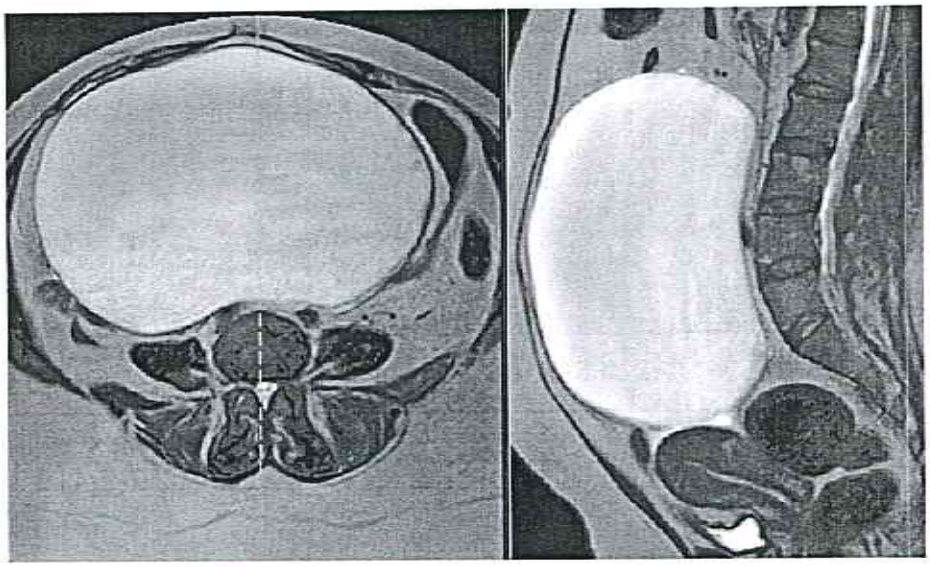
Patient Name: منال عثمان حسن	Study Date: 12/10/2026 12:16:45 PM

M.R.I. OF THE ABDOMEN & PELVIS

Technique:

- *Multiple sequences in different planes WITHOUT IV contrast.*

Findings:



- *Very large unilocular abdominopelvic cystic lesion, occupying most of the abdominal and pelvic cavities, with slight right-sided inclination, measuring approximately 15.5 × 20.5 × 21 cm (AP × TS × CC). The lesion displays predominantly fluid signal intensity, yet with relative T1 hyperintensity persisting on fat-suppressed images.*
- *Mild dependent internal signal heterogeneity is also noted. Additional note of numerous minute eccentric mural/endophytic nodular foci are seen along its inner wall, predominantly along the left aspect. The caudal aspect of the lesion closely abuts the visualized right ovarian tissue, raising the possibility of a right adnexal origin. The left ovary is not separately identified. The exact organ of origin remains uncertain.*
- *Marked mass effect upon the adjacent abdominal and pelvic viscera, with displacement of bowel loops and close abutment of the undersurface of the anterior abdominal wall.*
- *Minimal free pelvic fluid inferior to the lesion.*
- *Small right renal lower polar cortical cyst, showing posterior exophytic bulging, measuring approximately 2 × 2.5 cm.*

P.T.O.

sh

[[DOCTYPE:MRI]]
M.R.I

Fatth Islamic Center

C.T. - M.R.I

U.S. - Duppler - E.C.G. Stress

E.E.G - E.M.G - Mamm - Eye Unit

الجمعية الشرعية

مركز الفتح الإسلامى

أشعة مقطعية بالكمبيوتر - الرنين المغناطيسى
موجات صوتية - دوبلر ملون - رسم قلب بالمجهود
رسم مخ - رسم عضلات - فحص ثدى - وحدة عيون

تابع: منال عثمان حسن

- *Small right lateral uterine body intramural leiomyoma, measuring approximately 1.5 × 2.2 cm, displaying low T2 signal intensity.*
- *Incidental tiny (~3 mm) focal lesion at hepatic segment VI/VII, displaying low T1 and bright T2/IR signal intensity.*
- *Unremarkable rest of pelvi-abdominal organs.*
- *No pathological abdominopelvic lymphadenopathy.*
- *Mild divarication of the rectus abdominis muscles, measuring approximately 3.5 cm.*
- *Incidental asymmetric elevation of the right hemidiaphragm.*

***Side finding**: Scattered variable-sized dorsolumbar vertebral body haemangiomata, reaching approximately 2.5 cm.*

Conclusion:

- ***Huge abdominopelvic complex unilocular cystic lesion (~21 cm) exerting marked abdominopelvic mass effect, associated with minimal pelvic free fluid and containing multiple minute eccentric mural nodular foci. An ovarian/adnexal cystic neoplasm is the main consideration, possibly arising from the right adnexa. The mural nodular foci are worrisome and could represent solid papillary projections rather than adherent debris. Accordingly, a borderline epithelial ovarian neoplasm is suspected and cannot be excluded on this non-contrast examination. Further gynaecologic correlation is highly recommended.***

- ***Small uterine intramural leiomyoma.***
- ***Small right renal cortical cyst.***
- ***Incidental right hepatic lobe tiny focus (~3 mm), likely benign hepatic cyst.***
- ***No additional gross MRI abnormalities related to the abdomen & pelvis.***

Dr. Ramy El-Toukhy. MD

sh

٥٣ شارع ١٠ بالمعادى ت : ٢٣٥٨٧٣٣٢ - ٢٣٥٨٥٨١٩ - ٠١١٠٠١٥١٣٨٠ - ٠١٠٢٨٤٨٣٦٩٥